

26 - La présentation de l'épaule (Audio) - Pr. HAROU

Donc la présentation transverse, il n'y a pas grand chose à dire concernant la présentation transverse. Ça fait partie des présentations dystociques. Dans l'autre côté, on a les présentations autocyques et présentations dystociques.

Dans les présentations dystociques, vous avez les présentations défléchiques. Vous avez déjà étudié le front et la face de Briegma. Il y a ceux qui sont 100% dystociques et ceux qui sont partiellement dystociques.

Quand on parle de dystociques, on ne veut pas dire toujours par césarienne. Mais il y a celles qui sont totalement dystociques, comme la présentation de front, qui exactement va finir en césarienne. La présentation transverse fait partie de ces présentations totalement dystociques.

Puisque s'il y a un mot à dire, c'est que la présentation transverse est égale césarienne. On peut s'arrêter ici. Le problème de la présentation transverse n'est pas la conduite à tenir, mais c'est surtout le diagnostic, parce que le diagnostic parfois n'est pas facile.

Ça pose un diagnostic différentiel avec certaines présentations, notamment la présentation de siège. Pourquoi ? Est-ce que vous croyez que vous pouvez vous tromper sur une présentation de siège en la prenant pour une transverse et vice-versa ? Oui ? Déjà, difficile. Et même avant l'engagement, on va parler de fixation de la présentation avant l'engagement.

Vous allez suspecter le diagnostic lorsque la présentation est transversale. Non, parce que toutes les autres présentations sont longitudinales. Il y a une manœuvre assez séduisante.

Vous avez étudié dans le cours la manœuvre de Léopold. On va le voir. Cette manœuvre de Léopold, c'est la base de l'examen cétrical.

C'est la base. Pourquoi c'est la base ? Parce que c'est la base avec laquelle déjà vous allez faire un diagnostic. La dernière consultation du neuvième mois.

Parce que ce qui est intéressant, c'est déjà au neuvième mois que vous ayez une idée. Est-ce que c'est une présentation longitudinale ou transversale ? Est-ce que j'ai un pôle céphalique en bas ? Ou bien j'ai un pôle céphalique en haut ? Et ça vous pouvez faire juste avec la palpation. Vous n'avez pas besoin de toucher vaginale.

Avant que le col commence à s'ouvrir. Cette manœuvre est très importante, il faut la connaître. Et donc, on va voir, il ne faut pas se tromper.

Parce que le problème c'est quoi ? Le problème ce sont les femmes l'ont suivie et qui arrivent un jour au cours du travail, contractant avec une poche intacte et vous faites le toucher. Vous avez quelque chose de mou. Quelque chose de mou, très difficile de dire c'est quoi.

Surtout s'il y a de l'odème, etc. Vous ne savez pas si c'est un siège, si c'est une épaule. Est-ce que c'est un franc ? Est-ce que c'est une face ? Parfois les repères, vous savez le toucher vaginale, il est fait à l'aveugle.

Vous ne regardez pas, vous ne voyez pas les fesses, etc. C'est pour ça que dans les présentations, on choisit des repères fixes. Quel est le repère de la présentation de siège ? Le sacrum, qui est un repère osseux.

Quel est le repère de la présentation transverse ? L'acromion, tout à fait, qui est un repère osseux. Vous voyez que vous soyez anatomiste de naissance, faire la différence entre un acromion et un sacrum, vous voyez que c'est très difficile. Même par quelqu'un d'expérimenté, vous voyez une structure osseuse dure.

En plus, vous allez trouver du mou au-dessus. Donc parfois c'est difficile. Par contre, si vous palpez, dès le départ, un pôle céphalique en haut, un pôle mou, un siège en bas, avec une présentation longitudinale, vous savez que là vous êtes sur une présentation de siège.

Lorsque vous avez une excavation vite, vous palpez, vous ne palpez rien, ce qu'on appelle l'excavation vite, déjà avec une présentation transversale, vous êtes sur une présentation transverse. Ce qui ne nous importe pas vraiment la conduite à tenir, la prise en charge, on va le voir, c'est une césarienne, à part quelques cas exceptionnels, mais c'est de faire le diagnostic. Comme je vous l'ai dit, le diagnostic c'est difficile.

Et bien sûr, chaque fois qu'il y a une présentation transverse, vous vous dites pourquoi il y a une présentation transverse. Ça veut dire qu'il y a une étiologie qui a fait que le bébé n'a pas tourné, ce qui fait qu'il est resté en transverse. Il devrait tourner, il n'a pas tourné.

Soit il a tourné, il n'a pas tourné, soit il a tourné et tourné. C'est ce qu'on appelle l'excès de rotation. Le bébé céphalique, il est parti en transverse.

Et donc, les notions de base, c'est d'abord, quand on parle de présentation transverse, c'est une présentation dont l'axe du fœtus n'est pas vertical, il est transverse. D'accord ? On l'appelle la présentation de l'épaule, mais aussi présentation oblique, parce que parfois elle est oblique, pas toujours transverse, stricte. Donc, comme je vous dis, l'accouchement par les voies naturelles est théoriquement impossible.

Et cette présentation reste quand même assez rare dans la pratique. D'ailleurs, la rareté fait qu'on ne fait pas le diagnostic. Et plus elle est rare, plus les femmes sont suivies, plus peut-être on va, vous allez voir, c'est l'évolution naturelle.

Avant, on faisait beaucoup d'obstétrique d'urgence. La femme arrive, on travaille, on devrait décider sur un toucher vaginal. Et du fait que les médecins étaient très bons.

Là, les patientes sont suivies, déjà tout le monde commence à faire l'échographie, les généralistes, tous les généralistes commencent à faire l'échographie. Donc, n'importe quelle femme enceinte, il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas lui faire l'échographie. C'est devenu tellement une évidence qu'on va faire les diagnostics bien avant, on va les Césariser bien avant.

Donc, on va oublier les diagnostics au toucher vaginal. À un certain moment, il y aura quelqu'un qui va faire peut-être 5 ans de spécialité et ne va jamais toucher une présentation de l'épaule. Vous allez me dire, tant mieux.

Et si on diagnostique à l'échographie, le problème est résolu. Un jour, on va enlever ce chapitre, carrément. Et donc, la question aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on veut augmenter le taux de césarienne ou là on veut diminuer le taux de césarienne ? Qui veut diminuer ? Qui veut ? Vous.

Vous voulez diminuer. Vous. Vous parlez de vous-même.

Hein ? Donc, d'un côté, on a une pression de la société, une demande excessive sur les césariennes. D'accord ? Et d'une autre part, on a une morbidité liée à la césarienne. Mais qui fait le curseur ? Qui décide ? Qui décide ? Le médecin ? Non, le médecin ne devrait pas décider.

Parce que le médecin, c'est un humain qui fait des erreurs. C'est le système qui doit décider, pas le médecin. Parce que si on laisse, aujourd'hui, si on laisse tout le monde faire, tout le monde va Césariser tout le monde.

Personne ne va naître pas libre naturel. Donc, il faut créer un équilibre. L'équilibre vers les indications.

Aujourd'hui, au Maroc, on est en train de travailler sur ça. Mais par exemple, vous ne pouvez pas faire... Chaque césarienne faite dans un pays européen doit être justifiée. Pourquoi ? Parfois même, vous allez dire présentation de transverse, on va appeler la patiente, reprogrammer pour la présentation de transverse, on va appeler la patiente avec le médecin référent pour qu'il fasse l'échographie pour vérifier après vous si c'est vraiment une transverse ou un siège.

Et je vous dis ça, ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Et moi, personnellement, j'ai expérimenté, j'ai eu l'expérience d'expérimenter ce qu'on appelle ces nouveaux médecins. Comment on peut les appeler ? Non, pas les charlatans.

Pas les charlatans. C'est pas des charlatans. Ils cherchent petites bêtes, comme on dit.

En fait, ce qui est extraordinaire, il y a des médecins actuellement qui font ce travail, qui commencent à faire ce travail, surtout au niveau de la CNSS. Et c'est retrouvé qu'il y a quelques-uns, ils étaient de mes étudiants, ils étaient dans mon amphi comme vous voulez, peut-être dans 10 ans vous allez prendre leur place. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait des petits jeunes médecins qui sortaient de notre faculté, qui étaient embauchés à la CNSS comme médecins

conseils, qui vérifiaient, parce qu'il y a un dossier à moi qui a été revérifié par un petit jeune, il m'a appelé, il m'a dit « Usted, voilà, c'est Mélina ». Mon dossier était nickel, il n'y avait pas... Dans le système, le dossier a terminé chez ce petit médecin, jeune médecin je veux dire, jeune médecin, pas petit médecin, il n'y a pas de petit médecin, il y a médecin, jeune médecin qui a vérifié si mon indication, c'était dans une indication oncologique, pas dans l'indication d'obstétrique, si mon indication était bonne.

Donc son rôle, effectivement, il y aura des médecins comme ça qui vont contrôler, parce qu'il y a beaucoup de médecins malhonnêtes, qui vont dire « Je vais Césariser la patiente parce qu'il y a une présentation de siège ». Mais monsieur, est-ce que la présentation de siège est une indication de Césarien ? Le médecin conseil peut répondre « Votre demande de Césarien est refusée, parce que la présentation de siège n'est pas une indication formelle, il y a qu'on vous l'a enseigné dans le cours ». Et c'est comme ça qu'on pourra, grâce à ces médecins, ces jeunes médecins, peut-être parmi vous, il y aura des gens qui vont faire « Je vais Césariser la patiente parce qu'il y a une présentation de siège ». Qui est le médecin ? Non ? Médecin conseil, vous allez auditer tout le monde. C'est vous qui donnez l'accord. Donc il vérifie pour ne pas sortir du cadre, justement pour ne pas augmenter le taux de Césarien.

Sinon tout le monde fera des Césariens. Donc c'était entre parenthèses pour dire qu'il y a, qu'il faut faire attention, un jour on peut se retrouver de l'autre côté. Donc le but, vous allez voir dans la présentation de transfert, on peut augmenter un petit peu le taux de Césarien si on applique certaines mesures.

Même si on a dit que c'est vraiment Césarien, mais on va voir qu'il y a des gens qui ont réfléchi il y a très longtemps à des techniques pour diminuer le taux de Césarien. Alors, comme je vous l'ai dit, le repère c'est l'acromion. Et en fonction de la position de l'acromion, elle se pose vers 25, qui représentent 4 barrières antérieures, arrière, gauche, droite, postérieure.

Les premières sont appelées les présentations dorsaux antérieures, comme le tanine, c'est le dorsaux postérieur. Vous voyez, entre transverse et oblique c'est la même chose, on peut avoir, pas vraiment dans l'axe, mais à deux, dites positions obliques. Les autres c'est la position transverse stricte.

Ça c'est la même chose. Vous voyez que les diamètres sont incompatibles avec l'accrochement normal. Le bassin, on ne peut pas, sauf si on plicature ce bébé.

Si on le plicature comme ça, tac, il peut descendre. Eh bien, justement, cette question de plicature, c'est une piste pour dire, il y a un cas où on peut faire une plicature. Plicaturer un... Hein ? Tout à fait, la mort fatale.

Lorsqu'il y a une mort fatale, vous savez qu'avec la macération, il va se plicaturer sur une prématurité. Déjà le bébé est petit, tissu très très mou, il peut se plicaturer, on peut avoir un accouchement naturel. Ça serait dommage de faire un Césarien sur un bébé de 22 semaines à

23 semaines.

Macérer... C'est une des possibilités. On peut admettre l'accouchement naturel pour ne pas coller une cicatrice gratuitement. Les étiologies, on avait dit, soit c'est un problème d'excès de mobilité ou là, un problème de mal-rotation.

La multiparité, ça va être un excès de mobilité, avec un relâchement de la paroi. Le placenta prévia va être un problème de rotation. Les grossesses multiples, c'est un excès de mobilité, la même chose.

Les obstacles tels que prévia, telles que les kystes ou les fibras, ont un problème de rotation. Les enzymes encéphaliques des hydrocéphales, ça va être un problème de rotation aussi, parce qu'une des extrémités, par exemple l'hydrocéphale, va être très grosse, donc la culbute va le faire flotter vers le haut. L'hydramnios, excès de mobilité.

La grande prématurité, bien sûr, le prématuré est toujours mobile. Les disproportions phytopelviennes, les malformations, ça va être un problème de rotation. Le diagnostic, en général, il est intéressant de faire le diagnostic au 9ème mois, en regardant la transversalité de la présentation, toujours rechercher la limite, la tête, de quel côté elle est.

Donc, en général, la hauteur éthérienne va être petite, par rapport à l'âge gestationnel, c'est normal, parce que la présentation va être étalée transversalement. Et la palpation des pôles supérieurs et inférieurs de l'utérus ne se retrouve pas par le signe de l'opole, la tête ou le siège. Il va se retrouver dans les flancs, au lieu de se retrouver sur le système ombilical et en partie suspibine.

Mais c'est le toucher vaginal qui fait le diagnostic au cours du travail. La manière de l'opole, c'est surtout avant le travail, au cours du travail, c'est le toucher vaginal. Le toucher vaginal, si vous tombez sur une excavation vide, vous avez de la chance, si c'est vide, ça ne peut être que transverse.

Mais comme je vous ai dit, l'échographie aujourd'hui permet de faire le diagnostic, de confirmer le diagnostic, même parfois de regarder s'il n'y a pas d'éthiologie associée. La radio de contenu utérin, il y a longtemps, si vous êtes coincé, je ne sais pas si vous êtes coincé dans un patelin, vous êtes sûr que vous allez travailler tous dans un milieu urbain ? Vous êtes sûr ? La vie est pleine de surprises. Vous n'êtes pas sûr ? Vous pouvez travailler dans le rural, dans l'urbain, le Maroc peut rentrer en guerre demain, vous envoyer aux Franks avec des... Je ne sais pas.

Demain on rentre en guerre. On va vous envoyer tous aux Franks. Médecins militaires.

Il y a des radios comme des... des femmes qui vont accoucher. Il y a des radios comme des radios mobiles. Et la radio de contenu, vous pouvez faire une radio de mobile avec la radio de contenu pour voir la position des os du bébé par rapport au bassin.

Déjà, vous savez qu'en dire le signe. On ne sait jamais, un jour, vous en aurez besoin. Vous n'aurez pas d'échographie.

On ne sait pas comment on va terminer dans la vie. Voilà, la fameuse manœuvre de Leopold. C'est celle-là.

Donc, il y a quatre étapes. C'est comme ça qu'il faut faire. Palper le siège.

Après, palper le dos. Chercher le dos de quel côté. Après, palper la tête.

Chercher la tête. Bien sûr, c'est question aussi de pratique. Et donc, déjà là, vous avez un pôle céphalique.

Vous dites, il est situé où ? Le pôle caudal, le siège, il est situé où ? Si c'est au niveau des flancs, c'est transverse. C'est présentation transverse. Alors, si on ne fait rien, présentation transverse, on rentre au travail.

Si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer ? Lé ? Rupture utérine, très bien. Première complication. Le théoriste va se contracter, il va se remplir.

Donc, rupture utérine. Et bien sûr, s'il dit rupture utérine, mort fatale. Et après, une maladie, pronostic vital de la passion.

À part la rupture. Toujours la rupture ? Oui. Qui dit rupture ? Atonie, oui.

Atonie, c'est une complication post-opératoire. Si vous faites la césarienne, même transverse, vous avez un risque d'atonie. C'est-à-dire post-partum.

Complication tardive. Mais là, évolution naturelle. C'est-à-dire, patient qui rentre, il contracte, elle est dans la salle d'attente, son tour n'est pas arrivé, elle contracte, elle contracte.

Stagnation, oui. L'asphyxie. Mais comment il va s'asphyxier ? Voilà.

Il y a une complication grave. Ce qu'on appelle les pôles négligés. Ça s'appelle les pôles négligés.

Les pôles négligés, c'est des femmes qui vont venir aux urgences, comme ça. Imaginez, vous recevez une femme comme ça. La main dehors.

Qu'est-ce que vous allez faire ? Hein ? Le BCR, oui. Vous croyez que vous avez de la chance d'avoir du BCR positif ? Oui ? Césarienne. Vous pouvez... Le bébé, ça veut dire qu'il est très bas, il est déjà plicaturé pour le sortir césarien.

Et si je vous dis que c'est une morphéale ? Hum ? Surtout pas. Surtout pas. Déjà, quand on a ce tableau-là, vous allez palper la main, vous allez la trouver froide.

C'est un mot bleu. Et en général, 99% c'est une morphétale. Il est exceptionnel que le bébé soit vivant, sauf si, vraiment, c'est dans l'instant immédiat qu'elle a rompu la poche, qu'elle a mal aimé.

Mais en général, les pôles négligés, égal BCF négatif. Morphétale, c'est la césarienne, mais la césarienne difficile. Il faut vraiment la césarienne, il faut qu'un net repousse le bébé par le bas.

Parce que c'est très difficile. Le bébé, il est en général enclavé. Même la césarienne est très difficile.

Parce que la présentation est déjà engagée, enclavée, engagée, immobilisée. Et le problème avec ces présentations, en général, c'est, quand la pôle négligée dit, c'est-à-dire que les signes infectieux, en général, sont déjà installés. Et parfois, c'est des patientes qui viennent avec un sepsis.

La deuxième complication, donc on a eu de la rupture, la pôle négligée, c'est la procédance du cordon. Parce que l'excavation est vide, si le cordon peut descendre, bien sûr, il faut aller vers la césarienne parce qu'une procédance du cordon battant, en général, c'est césarienne. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire la rupture artificielle des membranes.

Si vous ne palpez rien, surtout pas remplir la poche. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, je ne palpe rien, je remplis la poche, comme ça je palpe. Ce qui est derrière.

Ah ben, vous rempez la poche, vous avez le cordon qui... Vous avez compris que le pronostic, bien sûr, s'il est très grave, si jamais la patiente vient tardivement avec une poche rompue, etc., mais il est très bon lorsque vous faites des diagnostics au négligement, vous faites la césarienne sans problème. Maintenant, comment prendre la patiente en charge, bien sûr, on avait dit que la prise en charge est claire, césarienne. Mais, comme je vous ai dit, les gens réfléchissent pour 10 minutes de césarienne.

Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, si on fait le diagnostic, à mon avis, un mois, on peut, s'il s'agit vraiment d'un problème d'excès de rotation, surtout hydramnios, surtout, lorsque vous avez un relâchement utérin multiparité, on peut essayer d'une version par manœuvre externe. Vous voyez, ça vous rappelle la manœuvre de Leopold. La même chose, on va essayer de pousser le bébé et le retourner juste en faisant des massages, le remettre soit en siège soit en céphalique.

C'est faisable. Dans beaucoup de pays, présentation, même le siège, on vous a dit, dans le siège, on peut faire une version par manœuvre externe. La même chose.

Dans beaucoup de pays, si vous faites le diagnostic de siège, le transverse, évidemment, si vous demandez la demande césarienne, le remboursement, ils vont vous dire est-ce que vous avez essayé la version par manœuvre externe. Il faut que vous ayez essayé la VME négative parce que la VME peut ne pas aboutir à la rotation du bébé. Il faut la essayer.

En général, le programme à 36 semaines s'autocolise et on prévient la patiente qu'on peut rentrer au bloc directement s'il y a une souffrance. On essaie la version. Si ça marche, on laisse la patiente tranquille.

Si elle devient encephalique, ça peut se transformer dans un cauchemar naturel. S'il y a un échec, à ce moment-là, bien sûr, on passe à la césarienne. Donc, c'est une façon de diminuer.

Il faut savoir que la césarienne n'est pas la solution facile parce qu'il faut faire une version par manœuvre interne au cours de la césarienne parce que aussi la césarienne est difficile. Il y a un risque de fusion, de grandes cicatrices, de déchirures associées, de fragilisation de l'utérus. On sait plus que la première césarienne fragilise l'utérus, plus le risque de rupture utérine sur les césariennes à venir est beaucoup plus important.

Donc, la césarienne n'est pas la solution miracle, surtout pour les grossesses ultérieures. Puis, il y a une troisième indication pour diminuer toute césarienne, surtout si vous avez une grossesse jumelée. Le premier, par exemple, est encephalique, si vous voulez un siège.

Le deuxième est en transverse. Si le deuxième est en transverse, il faut essayer de ne pas entrer en césarienne. Vous avez accouché le premier, vous vous dites transverse le deuxième, on va aller en césarienne.

Il faut faire ce qu'on appelle une version par manœuvre interne et c'est terminant par ce qu'on appelle la grande extraction de siège. On vous a parlé de ça au cours de la présentation de siège. Donc, version par manœuvre interne, transformant une présentation de siège en présentation transverse en présentation de siège, et terminer par la grande extraction de siège.

Donc, surtout pas césarisé, c'est ce deuxième jumeau. C'est clair ? C'est ça les indications principales d'un accouchement naturel dans les présentations transverse, sinon, tout le reste va être en césarienne. Une césarienne.

Mais, la version par manœuvre externe, en général, il faut l'essayer avant. Il faut juste choisir les bonnes patientes, les bonnes indications avant de la faire. Et bien sûr, le faire dans un milieu hospitalier, pas en consultation.

Hospitaliser la patiente, faire un talk release, un nurse monitoring, et être prêt au du bloc si jamais il y a un problème qui arrive. Et donc, vous voyez que la présentation transverse reste une pratique assez rare en obstétrique. Deux choses à retenir.

Recherchez l'étiologie. Et puis, césarienne de gauche standard, mais tout en ayant la possibilité d'accoucher par les voies naturelles, si une version par manœuvre externe est possible. Voilà, je vous remercie, et bon courage pour la suite.

Je crois que j'ai terminé avec vous. Il vous reste les cours du professeur Soumanis, c'est ça ? Et

professeur ? Non, c'est fini ? Ça fait ? Parfait ? En tout cas, ce n'est pas moi qui vais vous faire les avortements. Ce n'est pas prévu.

Parce que les choses, on décide dès le départ. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Normalement, la rotation survient à la fin du huitième mois. Normalement, elle est fixée le neuvième mois, sauf s'il y a un excès de rotation, comme je vous dis.

Et bien sûr, c'est pour ça que quand vous faites les diagnostics, vous proposez une version par manœuvre externe. Vous la voyez, la consultation, quand je vous parle dans mes mois, j'ai un 35-36 semaines. Vous allez voir la patiente, vous allez lui proposer.

Dans la semaine, vous allez la revoir pour une version par manœuvre externe, s'il y a possibilité. Vous refaites l'échographie, vous faites l'examen. S'il a tourné, c'est bon.

S'il n'a pas tourné, vous essayez de le tourner. D'accord ? C'est ce qu'il faut. C'est pour ça que j'insiste sur l'examen du neuvième mois.

Quand vous avez... Vous faites la rupture artificielle quand vous avez déjà une idée sur une présentation. C'est-à-dire, vous palpez quelque chose. Et si vous avez une excavation vide, c'est vide, il n'y a rien.

Je vous ai dit, parfois ce qui arrive, c'est qu'il y a des sages femmes qui font la rupture juste pour dire puisque je ne palpe rien, comme ça, ça va descendre. Il ne faut pas faire la rupture artificielle. Normalement, on fait quand la rupture artificielle des membranes ? Là, non.

C'est pour accélérer le travail, en général, à partir de trois centimètres avec une présentation fixée. C'est au moins les critères. Donc, il faut avoir une présentation fixée au moins trois centimètres pour faire la rupture artificielle des membranes pour accélérer le travail.

Si elle est fixée, non. Et si c'est la... C'est tes questions ? C'est bon ? Des questions pour les autres cours ? Voilà, bon courage.